



CUIDADO CARIÑOSO
Y SENSIBLE PARA EL DESARROLLO EN LA PRIMERA INFANCIA

Cuidado cariñoso y sensible e implicación de los hombres



¿Por qué son importantes los hombres para el cuidado cariñoso y sensible?

En el Marco para el cuidado cariñoso y sensible (1) se destaca la importancia del papel de los hombres como cuidadores, junto con las madres, los abuelos y las abuelas, y otras personas. El consenso en este sentido es cada vez mayor y, aunque todavía se dispone de pocas pruebas, su número va en aumento.

Estas pruebas, que se resumen en el recuadro «Los beneficios de la participación de los hombres», en la página 2, muestran que, cuando estos se implican de manera afectuosa, equitativa y no violenta en el cuidado de los niños pueden contribuir a mejorar los resultados de los niños y las niñas, las mujeres y ellos mismos (2, 3, 4). Los estudios demuestran también que la existencia de varios cuidadores cariñosos, independientemente de su género, beneficia a los niños y las niñas (4), y los datos procedentes de varios

países indican que muchos hombres desean implicarse más en la vida de sus hijos e hijas y están interesados en aprender a cuidar mejor (5).

Sin embargo, muchos niños y niñas no llegan a beneficiarse plenamente del cuidado cariñoso y sensible de su padre y de otros hombres cuidadores. En la mayoría de los países, ya sean de ingresos bajos, medianos o altos, las mujeres siguen siendo en gran medida o incluso exclusivamente las responsables de cuidar a los niños y niñas en el hogar, aun cuando su participación en el mercado laboral sea mayor (4).

Este documento está dirigido a los responsables de la formulación de políticas y a las personas encargadas de la elaboración de programas. En él se tratan los aspectos que deben tenerse en cuenta al diseñar o adaptar servicios para promover la implicación de los hombres en el cuidado cariñoso y sensible, y se explica por qué es importante que lo hagan. El texto resume los conocimientos y la experiencia acumulados hasta la fecha y propone medidas prácticas en cuatro entornos facilitadores —las políticas, los servicios, las comunidades y los cuidadores—, ilustradas con estudios de caso. La atención se centra especialmente en las medidas que pueden adoptarse en el seno de los servicios de salud, aunque también se abordan los sectores de la educación y la protección social, entre otros.

¿En qué consiste el cuidado cariñoso y sensible?

Lo que sucede durante la primera infancia (del embarazo hasta los 8 años) sienta las bases para toda la vida. Hemos hecho grandes progresos en la mejora de la supervivencia infantil, pero también tenemos que crear las condiciones adecuadas para ayudar a las niñas y niños a prosperar a medida que crecen y se desarrollan. Esto requiere proporcionar a los niños cuidados cariñosos y sensibles, especialmente en sus primeros años de vida (desde el embarazo hasta los 3 años).

El cuidado cariñoso y sensible comprende cinco componentes interrelacionados e indivisibles: buena salud, nutrición adecuada, seguridad y protección, atención receptiva y oportunidades para el aprendizaje temprano. El cuidado cariñoso y sensible protege a las niñas y niños de los peores efectos de la adversidad y produce beneficios intergeneracionales y de por vida para la salud, la productividad y la cohesión social.

El cuidado cariñoso y sensible ocurre cuando se aprovecha al máximo cada interacción con la niña o el niño. Cada momento, breve o largo, estructurado o no estructurado, es una oportunidad para garantizar que los niños estén sanos, reciban alimentos nutritivos, se mantengan seguros y aprendan sobre sí mismos, sobre los demás y sobre su mundo. Lo que hacemos importa, pero la forma en que lo hacemos todavía importa más.

Los beneficios de la participación de los hombres

Para las mujeres

- La participación activa y el apoyo de los hombres durante el embarazo aumentan la probabilidad de que la madre reciba atención prenatal, asistencia durante el parto y atención posterior al parto, y contribuyen a que la familia esté mejor preparada frente a posibles complicaciones (6). Además, puede ayudar a reducir la depresión posparto de la mujer (6, 7). Estas conclusiones se han obtenido tras analizar los resultados de intervenciones diseñadas para fomentar la implicación de los hombres (2, 6, 8-10).
- Cuando los hombres acompañan a las mujeres durante el trabajo de parto y el alumbramiento, pueden ayudar a reducir su estrés y malestar (4, 11).

Para los niños y niñas

- Las intervenciones destinadas a mejorar los conocimientos, las actitudes y las prácticas de los hombres sobre nutrición materna e infantil durante el embarazo, el parto y el posparto pueden favorecer la lactancia materna exclusiva y la nutrición tanto de los lactantes como de sus madres (12).
- El cuidado y la interacción directa de los hombres con los lactantes y los niños pequeños pueden contribuir a su desarrollo cognitivo, social y emocional, así como favorecer su preparación para la escuela y su rendimiento académico posterior (3, 9, 13, 14).
- La implicación directa de los hombres en el cuidado durante la primera infancia puede favorecer la salud mental de los niños y se asocia con una menor incidencia de problemas conductuales en los niños y de problemas psicológicos en las mujeres jóvenes (4, 13-15). Además, puede ayudar a desarrollar la empatía hacia los demás (3, 14).

Para los propios hombres

- La implicación de los hombres y el reparto de las responsabilidades del cuidado, desde el embarazo, pueden mejorar sus relaciones con sus cónyuges e hijos y aumentar tanto su salud física y mental como su felicidad en general (4, 11).

Para toda la familia

- Se ha demostrado que las intervenciones sobre la crianza que incluyen explícitamente, como cuidadores, a hombres y mujeres producen efectos positivos en las relaciones tanto conyugales como familiares, como una comunicación más fluida, una adopción de decisiones más equitativa, unas relaciones sanas y respetuosas entre los hombres y sus cónyuges, y una disminución de la violencia contra las mujeres y los niños, incluidos los actos violentos presenciados por los niños contra sus madres (8, 11, 16, 17).

Definiciones

Hombres cuidadores

En este documento se emplea de forma indistinta el término **padre** y **hombre cuidador** para designar a los varones que desempeñan una función principal para cuidar a los niños pequeños, ya sean padres biológicos o adoptivos, padrastros, abuelos, tíos, tutores u otros familiares. Además, se reconoce que estos hombres pueden presentar características diversas en cuanto a edad, origen étnico, capacidades, identidad de género y orientación sexual. También se tiene en cuenta que algunos hombres crían a sus hijos solos, con su cónyuge o con otro progenitor, que pueden o no convivir con los hijos, y que la familia puede adoptar distintas formas.

Implicación

Se considera que los padres y otros hombres cuidadores están **implicados** cuando tienen una presencia emocional, responden de manera activa y sensible y contribuyen activamente a proteger, apoyar y promover la salud, el desarrollo y el bienestar de los niños. Si mantienen una relación con la otra persona encargada de cuidar, implicarse también supone compartir las responsabilidades domésticas y de crianza, y mantener una relación sana, respetuosa, no violenta, afectuosa y equitativa. No existe un único modelo de paternidad comprometida y debe prestarse apoyo a cada familia para que pueda tomar las decisiones que mejor se adapten a su situación. Lo importante es que los hombres cuenten con respaldo para redefinir sus formas de cuidado y establecer vínculos más significativos con sus seres queridos.



¿Cuáles son los componentes del cuidado cariñoso y sensible?

BUENA SALUD



Concierne a la salud y el bienestar de las niñas y niños y sus cuidadores. ¿Por qué ambas cosas? Sabemos que la salud física y mental de los cuidadores puede afectar su capacidad para cuidar a la niña o niño.

NUTRICIÓN ADECUADA



Concierne a la nutrición de la madre y la niña o niño. ¿Por qué ambas cosas? Sabemos que el estado nutricional de la madre durante el embarazo afecta a su salud y bienestar y a los del bebé por nacer. Después del parto, el estado nutricional de la madre afecta su capacidad para amamantar y proporcionar un cuidado adecuado.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN



Se refiere a la disponibilidad de entornos seguros y protegidos para las niñas y niños y sus familias. Incluyen los peligros físicos, el estrés emocional, los riesgos ambientales (por ejemplo, la contaminación) y el acceso a alimentos y agua.

OPORTUNIDADES PARA EL APRENDIZAJE TEMPRANO



Hace referencia a todas las oportunidades para que el bebé o la niña o niño pequeño interactúen con una persona, lugar u objeto en su entorno. Reconoce que cada interacción (positiva o negativa, o falta de interacción) está contribuyendo al desarrollo del cerebro la niña o niño y sentando las bases para su aprendizaje posterior.

ATENCIÓN RECEPTIVA



Concierne a la capacidad del cuidador para percibir y entender las señales de su hijo y para darles respuesta de manera oportuna y apropiada. Se considera el componente fundamental porque los cuidadores receptivos tienen mayor disposición a apoyar los otros cuatro componentes.

¿Cuáles son los obstáculos a la implicación de los hombres?

En todo el mundo, las mujeres siguen asumiendo la mayor parte de las tareas de cuidado. Existen diversos factores que explican que los hombres se impliquen menos en ellas, entre ellos la percepción generalizada de que las mujeres poseen una capacidad más innata para cuidar de los niños y velar por su salud y desarrollo, mientras que los hombres carecen de aptitudes para hacerlo, no son competentes o simplemente no muestran interés en este tema (17, 19).

Estas percepciones son fruto de las normas de género, es decir, de las expectativas y reglas informales que las comunidades y las sociedades establecen sobre cómo deben comportarse las mujeres y los hombres y cuáles deben ser sus funciones. Dichas normas influyen enormemente en las expectativas de ambos —como progenitores, como cónyuges y respecto a sus hijos—. En muchos lugares se espera que el hombre proteja a la familia, aporte su sustento económico y asuma la responsabilidad de tomar decisiones, y se le educa para ello, pero no se da por hecho que tenga que participar tanto en el cuidado cotidiano de los niños. También puede ocurrir que el hombre que desee implicarse más en ese cuidado se vea desalentado por personas de su entorno, como compañeros, familiares o amigos.

Desde edades muy tempranas, las niñas y los niños interiorizan estos roles y normas de género a través de sus experiencias cotidianas con los adultos. Muchos niños varones que crecen sin ver a hombres implicados en cuidar no adquieren la confianza, los conocimientos ni las habilidades necesarias para criar a sus propios hijos más adelante. Por ello, es importante tener en cuenta lo que hacen tanto las mujeres como los hombres y también la manera en que se relacionan entre sí.

Las expectativas para cada género también pueden influir en la elaboración y la prestación de las políticas, los servicios y las infraestructuras disponibles para la primera infancia, que a menudo pasan por alto a los hombres o incluso los excluyen. En muchas ocasiones, los servicios de salud materna, neonatal e infantil, de atención a la infancia, de educación inicial y de protección social y de la infancia se conciben pensando solamente en las mujeres, lo que refuerza las expectativas desiguales sobre quién debe cuidar a los niños.

¿Qué estrategias favorecen la implicación de los hombres en el cuidado cariñoso y sensible?

Cada vez se dispone de más pruebas sobre el modo de fomentar la implicación de los hombres en el cuidado cariñoso y sensible y lograr resultados positivos.

En este apartado se presentan las principales enseñanzas extraídas de los programas basados en datos empíricos, que también pueden aplicarse en los sistemas de salud y educación y en otros ámbitos que prestan apoyo a los niños y a sus familias (véase el recuadro «Implicar a los hombres: cuatro enseñanzas fundamentales»).

Implicar a los hombres: cuatro enseñanzas fundamentales

- 1 Respetar y promover los derechos de las niñas y las mujeres.
- 2 Apelar a los hombres y favorecer el apoyo mutuo.
- 3 Integrar esta labor en las actividades más amplias destinadas a alcanzar la igualdad de género.
- 4 Respaldar al personal de primera línea para que reflexione sobre sus propias actitudes con respecto a los géneros y refuerce sus capacidades.

1 Respetar y promover los derechos de las niñas y las mujeres

Escuchar a las mujeres y obtener su consentimiento

Las mujeres deben participar desde el principio en la concepción de las iniciativas dirigidas a hombres cuidadores. Los servicios deben atender sus necesidades y preocupaciones, resaltar la importancia de la igualdad de género y del respeto a las decisiones de las mujeres, y recabar la opinión de las mujeres sobre la calidad de los servicios. Su consentimiento es fundamental para llevar a cabo iniciativas orientadas a aumentar la implicación de los hombres en los servicios destinados a las mujeres, como los de maternidad.

Cuando se incentive la implicación de los hombres, no se debe perjudicar a las mujeres

Al fomentar la implicación del padre no se debe menoscabar la seguridad, la autonomía ni el acceso de las mujeres a los servicios. Si no se planifican con cuidado, las iniciativas destinadas a incentivar la participación de los hombres pueden obstaculizar la búsqueda de atención por parte de las mujeres y negarles el acceso a servicios fundamentales. Por ejemplo, esto podría suceder si se exige la presencia de los hombres para inscribirse o recibir atención prenatal, o si se da prioridad a las parejas frente a las mujeres solas o no acompañadas.

Asegurarse de que el personal que presta servicios no refuerce las desigualdades entre los géneros

Si el personal no está bien preparado para interactuar con los hombres junto a sus cónyuges ni para comprender y evitar los desequilibrios de poder entre mujeres y hombres, puede acabar escuchando y dando preferencia al varón en lugar de a la mujer. De este modo, aunque sea de forma involuntaria, puede reforzar las desigualdades entre los géneros y socavar la autonomía y la capacidad de decisión de las mujeres. También puede ocurrir lo contrario: que los trabajadores no tengan en cuenta a los hombres presentes, con lo cual desaprovechan la oportunidad de fomentar su implicación y los desalientan de implicarse en el futuro.



Ofrecer a las mujeres cuidadoras oportunidades para reflexionar y aprender

La eficacia de las intervenciones también se mide por su capacidad de incluir a las mujeres y ofrecerles espacios para reflexionar sobre las normas y actitudes de género, cuestionarlas y, junto con sus cónyuges, reconocer los beneficios del cambio, así como las medidas que adoptarán conjuntamente.

2 Apelar a los hombres y favorecer el apoyo mutuo

Diseñar servicios que conecten con los hombres y reflejen sus aspiraciones

Los servicios deben concebirse de modo que conecten con los hombres y reflejen sus expectativas respecto a sus hijos, sus familias y ellos mismos como cuidadores y como cónyuges. Los trabajadores de primera línea deben reconocer que los varones se preocupan por sus hijos, desean lo mejor para ellos y quieren cuidar lo mejor posible.

Adoptar un enfoque práctico basado en los puntos fuertes en lugar de limitarse a transmitir información

Debe partirse de lo que los hombres ya saben y aplican, y ayudarles a resolver las cuestiones que afrontan, reforzando su confianza como cuidadores. Se debe promover el aprendizaje activo y práctico, que tenga en cuenta las distintas formas de aprendizaje y las experiencias vitales. Es importante aprovechar las normas y prácticas positivas existentes que favorecen el cuidado por parte de los hombres, así como determinar cuáles de ellos ya están implicados para ayudarles a que animen a otros a hacer lo mismo.

Adaptar las explicaciones a la diversidad de los hombres

No basta simplemente con incluir a los hombres en los programas existentes de educación y apoyo a la crianza: es necesario adaptar los programas a las circunstancias locales y adecuar su contenido a las necesidades de los distintos tipos de hombres y de modelos familiares, teniendo en cuenta las familias extensas, nucleares y monoparentales, así como los padres adoptivos, los padres adolescentes y los que no conviven con sus hijos. También debe velarse por integrar en los programas a las familias en situación de vulnerabilidad, como las refugiadas o desplazadas, y a los cuidadores con distintas capacidades, identidades de género y orientaciones sexuales.

Crear entornos seguros y de apoyo donde los hombres puedan dialogar y poner en práctica nuevas habilidades

Los hombres necesitan espacios seguros donde expresar sus inquietudes, reforzar su confianza y practicar nuevas habilidades, como establecer un vínculo afectivo con el recién nacido mediante el contacto piel con piel, el baño, la alimentación de los niños pequeños o el manejo de su comportamiento. Además, deben poder aprender y practicar formas equitativas de relacionarse con sus cónyuges, como la resolución no violenta de conflictos, la comunicación y la adopción conjunta de decisiones.

Fomentar el apoyo y el aprendizaje entre iguales

Deben promoverse las redes de apoyo mutuo entre hombres y propiciar que estos aprendan unos de otros y colaboren para buscar soluciones a sus problemas. Se los debe alentar a relacionarse con sus amigos y compañeros para promover un cambio sostenible en todo su entorno social.

3 Integrar esta labor en las actividades más amplias destinadas a alcanzar la igualdad de género

No limitarse a la educación sobre la crianza

La simple inclusión de hombres en programas de educación sobre la crianza puede no bastar para transformar las normas de género. Es preciso determinar y abordar los factores que influyen en las conductas paternas y los obstáculos a su implicación, incluidas las normas restrictivas de género. Este proceso debe estar guiado por el entorno social, centrarse en él y ser respetuoso con sus valores. Asimismo, puede ser necesario colaborar con los proveedores de servicios e influir en las políticas y en las estrategias de comunicación sobre cambio social y de comportamiento, aspectos todos ellos que se describen más adelante.

Ofrecer activamente oportunidades para reflexionar sobre las normas, actitudes y roles de género

Deben ofrecerse a los cuidadores y a los miembros de su entorno social de todos los géneros espacios para reflexionar sobre el modo en que las normas de género influyen en las funciones que desempeñan las mujeres y los hombres en las tareas de cuidado, en sus relaciones y en la forma como se crían las niñas y

los niños. Es importante adaptar los contenidos a las normas, las políticas y los obstáculos propios de cada lugar que dificultan la implicación de los hombres. Se recomienda emplear métodos participativos de aprendizaje para ayudar a los hombres a entender cómo el cambio de actitudes y de dinámicas de poder puede beneficiar a las mujeres, a los niños y a ellos mismos.

Reconocer que los hombres, las mujeres y las familias pueden recibir respuestas adversas

Cuando los hombres desafían las normas y asumen responsabilidades de cuidado tradicionalmente atribuidas a las mujeres, tanto ellos como sus cónyuges pueden ser objeto de burlas, aislamiento o incluso de actos más graves. Los responsables de estas actitudes pueden ser las cónyuges, los amigos, los familiares, los líderes comunitarios o el personal que presta servicios. En ocasiones, será necesario prestar apoyo individual a los hombres, las mujeres o sus cónyuges para ayudarles a mitigar esos riesgos, al tiempo que se trabaja con las comunidades para modificar las normas de género.

Fortalecer las relaciones conyugales y las competencias para la crianza

Es preciso trabajar con las parejas para reforzar sus habilidades de comunicación, la adopción conjunta de decisiones y la gestión de conflictos, con el fin de fomentar relaciones equitativas entre mujeres y hombres y promover el cuidado cariñoso y sensible. Consolidar los vínculos conyugales puede ayudar a prevenir la violencia en la relación, mejorar el entorno familiar en el que crecen los niños y reducir el riesgo de violencia contra ellos (15). El trabajo con las parejas también puede favorecer que los hombres asuman como propias las tareas domésticas y el cuidado infantil y ayudar a los cuidadores a criar a niños y niñas de forma equitativa.

Trabajar para transformar las actitudes de las personas que influyen en la vida de los hombres

Las personas que más influyen en la vida de los hombres son sus cónyuges, sus padres y suegros, sus hermanos y demás familiares, sus amigos, los dirigentes comunitarios y los líderes religiosos, las personas mayores y los principales proveedores de servicios. Todas ellas pueden tanto facilitar como limitar la implicación de los hombres en la vida de sus hijos, por lo que es importante tratar de modificar sus actitudes y expectativas.

Hacer participar a los hombres, las mujeres y los dirigentes comunitarios en la concepción de los programas

La participación de estas personas contribuye a que los programas reflejen las necesidades, las aspiraciones, los temores y las dificultades de los hombres como cuidadores, y a que cónyuges tengan en cuenta el deseo y la preocupación de las mujeres de que sus parejas colaboren más para cuidar a los niños. Además, permite determinar las modalidades, los momentos y los lugares más adecuados, así como seleccionar y contratar personal o proveedores de servicios que gocen de la confianza y el respeto del entorno social.

4 Respaldar al personal de primera línea para que reflexione sobre sus propias actitudes con respecto a los géneros y refuerce sus capacidades

Es preciso fomentar la reflexión de las personas que trabajan con hombres y con familias acerca de sus actitudes con respecto a las relaciones entre mujeres y hombres.

Los educadores, los coordinadores, los trabajadores de la salud y otros proveedores de servicios suelen tener las mismas actitudes y expectativas predominantes sobre el género y el cuidado que el resto de la población. Es fundamental que dispongan de tiempo y espacio para reflexionar, de modo que comprendan y valoren la importancia de la implicación de los hombres y de la igualdad de género

Aumentar la capacidad del personal de primera línea para implicar a los hombres

Es preciso ofrecer una supervisión constante, acompañamiento y mentoría al personal de primera línea para que sepa prestar apoyo eficazmente a los hombres cuidadores. Ello implica fomentar la reflexión y el diálogo, aprender a escuchar y orientar sin juzgar ni reprender, y gestionar los conflictos con tacto.



Un futuro padre lleno de orgullo apoya cariñosamente a su pareja, compartiendo la alegría de una familia que crece en Rwanda. ©Perttu Saralampi

¿Qué medidas pueden adoptarse?

A fin de aprovechar plenamente el potencial de los hombres para cuidar de forma cariñosa y sensible, debe adoptarse un enfoque que abarque a toda la sociedad y que implique cambios en las políticas, los servicios, las comunidades y las familias.

En los cuatro apartados que figuran a continuación se proponen medidas para fomentar la implicación de los hombres en cada uno de los entornos que facilitan el cuidado cariñoso y sensible (véase la figura).

Políticas propicias

Se proponen medidas políticas, entre otras, formular reglamentos y leyes que rijan los servicios y programas relacionados con la primera infancia y que mejoren la capacidad de los hombres para ofrecer un cuidado cariñoso y sensible.

Revisar las políticas y normativas del sector de la salud

Es necesario facilitar que los hombres participen en la atención prenatal y el parto, en los servicios posteriores al parto para mujeres y en la atención esencial a la salud infantil, ofreciéndoles espacios adecuados y privacidad, siempre con el consentimiento de las mujeres.

Deben adaptarse los procedimientos operativos, los planes de estudio para el personal de salud y las normas de las infraestructuras a fin de favorecer la implicación de los hombres.

También se ha de velar por que haya suficiente personal, un volumen de trabajo razonable y presupuestos suficientes que permitan que los trabajadores promuevan la participación de los hombres sin comprometer ni retrasar la calidad de la atención.

Elaborar políticas, planes y presupuestos integrales de desarrollo en la primera infancia

Al formular o revisar políticas, planes y presupuestos, es necesario aplicar un

Figura. Entornos propicios para el cuidado cariñoso y sensible (1).



enfoque centrado en la familia, que transforme las relaciones entre los géneros y tenga en cuenta los distintos modelos familiares, así como el hecho de que pueden cuidar personas de todos los géneros (véase el caso de Chile).

Deben definirse intervenciones intersectoriales que posibiliten y promuevan la implicación de los hombres en el cuidado cariñoso y sensible, y asegurarse de que se incluyan en los presupuestos.

Reforzar las políticas de educación y atención en la primera infancia

Se debe exigir y financiar que los educadores y los responsables reciban formación antes y durante el desempeño profesional para fomentar la implicación de los hombres cuidadores en el aprendizaje de los niños pequeños.

Asimismo, es necesario revisar las estrategias de contratación y desarrollo profesional con el fin de aumentar el número de varones que acceden a las profesiones relacionadas con la atención y la educación en la primera infancia y que permanecen en ellas.

Incluir licencias parentales remuneradas en las políticas de protección social

Es preciso asegurarse de que se ofrezcan suficientes licencias de maternidad remuneradas a las mujeres y preverlas también para los hombres, que tienden a utilizarlas más cuando son flexibles, de duración suficiente, remuneradas y no transferibles al cónyuge (véase el recuadro sobre licencias parentales y el estudio de caso de Filipinas).

Además, estas licencias deben ampliarse para que los cuidadores, con independencia de su género, puedan ausentarse en otras etapas del crecimiento de sus hijos, por ejemplo, cuando un niño está enfermo o cuando se dispone de pocos servicios de cuidado infantil.

Monitorear y evaluar las políticas y las intervenciones

Se debe hacer un seguimiento de la implicación de los hombres, tanto en los servicios como fuera de ellos, pero sin considerar que dicha participación sea un fin en sí misma. Lo prioritario es mejorar la calidad y los resultados de los servicios, especialmente para los niños y las mujeres.

Asimismo, es preciso evaluar los resultados de las actividades encaminadas a aumentar la implicación de los hombres, mediante la observación directa y la recopilación de las opiniones de los usuarios, con el fin de detectar posibles efectos negativos sobre el acceso de las mujeres a los servicios de salud o sobre la calidad de estos. También es importante velar por que la implicación de los hombres no refuerce involuntariamente relaciones de poder desiguales ni limite la autonomía de las mujeres.

Igualmente, se debe promover la participación comunitaria en los mecanismos de rendición de cuentas a la sociedad, por medio de métodos como la vigilancia participativa, los informes ciudadanos y las tarjetas de evaluación con el fin de valorar la calidad de los servicios, introducir mejoras que favorezcan la implicación de los hombres y responder a las necesidades y prioridades del entorno social.

Licencias parentales para los hombres cuidadores

Las licencias parentales constituyen una excelente oportunidad para que los hombres fortalezcan los vínculos con sus hijos desde el principio y los cuiden de forma más activa. Además, les permiten brindar apoyo físico, emocional y social a sus cónyuges durante el periodo posparto y compartir las responsabilidades domésticas y en las tareas de cuidado, especialmente cuando las parejas pueden decidir conjuntamente cuándo tomarlas.

Sin embargo, las políticas sobre licencias parentales varían considerablemente según el país. Menos de la mitad contemplan

licencias para los padres, y la mayoría solo cubren a los trabajadores asalariados del sector regulado (19). Además, muchos hombres no las utilizan porque son demasiado cortas o mal remuneradas, o porque temen ser estigmatizados o marginados por sus empleadores (4, 19). En otros casos, las políticas no abarcan a todos los cuidadores y excluyen a los trabajadores por cuenta propia, a los desempleados o subempleados, a quienes trabajan en el sector informal o a las familias no tradicionales.

Es preciso ampliar las políticas de licencias parentales remuneradas y estudiar sus efectos para que todos

los cuidadores puedan beneficiarse de ellas. Los responsables y el propio personal deben conocer las ventajas de estas políticas, tanto para los lugares de trabajo como para los hombres y sus familias. Asimismo, es necesario fomentar que los hombres aprovechen estas licencias, afrontando la estigmatización que las rodea y cuestionando las ideas presentes en los lugares de trabajo que desincentivan su uso.

Para más información, véase el documento informativo del [UNICEF sobre las licencias parentales](#).

CHILE

Un enfoque normativo centrado en la familia que respeta la igualdad de género

«Chile crece contigo» es un sistema nacional integral, que abarca desde el periodo prenatal hasta los 9 años, cuyo objetivo es proteger a los niños y las niñas y ayudarlos a desarrollar plenamente su potencial. Se basa en aprovechar todos los encuentros entre los niños, sus cuidadores y los servicios de salud, y ofrecer servicios coordinados en todo el sector público, incluidos los ámbitos de la educación y del desarrollo social.

Este programa pretende dejar atrás planteamientos anteriores que solían centrarse únicamente

en las madres, y utiliza el concepto de *parentalidad* para superar la visión de la paternidad y la maternidad como actividades separadas. Con ese fin, se anima a los padres varones a estar presentes en el nacimiento de sus hijos, y se difunden materiales adecuados, como vídeos sobre paternidad activa y corresponsabilidad que muestran imágenes de hombres cuidadores.

Se han realizado numerosos estudios que han demostrado los efectos positivos de este programa en el desarrollo de los niños y en la

satisfacción vital de los progenitores. Por esta razón, otros países de la región están adoptando políticas de primera infancia más integrales que incluyen a los padres, como hace el Uruguay con su Sistema de Cuidados.

Para más información, véase el estudio de caso detallado publicado en el [BMJ](#).



Licencias parentales remuneradas para los padres

En 1996, Filipinas aprobó la Ley de Licencia por Paternidad, que otorgó siete días de licencia remunerada por paternidad a los padres casados que convivían con su cónyuge. La remuneración corría a cargo de los empleadores, tanto del sector público como del privado, y podía obtenerse hasta el cuarto hijo. Esta ley abarcaba los casos de parto, aborto espontáneo, interrupción voluntaria del embarazo y adopción de niños menores de 7 años.

En 2019, una nueva ley amplió los derechos de licencia por maternidad y por paternidad, de manera que las madres pueden transferir hasta siete días de licencia parental remunerada a su cónyuge, independientemente del estado civil. Esta legislación demuestra el compromiso del Gobierno con la implicación de los padres en el cuidado cariñoso y sensible. Desde entonces, la Autoridad Nacional de Economía y Desarrollo ha recomendado ampliar tanto la licencia por paternidad como la parental, reconociéndolas como instrumentos normativos importantes para aumentar las

mujeres y promover la igualdad de género en el cuidado infantil dentro de las familias.

A pesar de estas políticas, hay varios factores que impiden que muchos padres hagan uso de las licencias por paternidad en Filipinas. Más de la mitad de los trabajadores están empleados en el sector informal y, por tanto, no tienen acceso a licencias financiadas por empleadores. Además, en este país sigue habiendo normas de género restrictivas sobre las funciones de los hombres como padres y sobre su responsabilidad en las tareas de cuidado. Muchos temen sufrir perjuicios económicos o profesionales si aceptan las licencias a las que tienen derecho por ley. Además, solo los hombres casados pueden disfrutarlas, lo que excluye a muchos tipos de familias presentes en la sociedad (21).

Todo ello demuestra que, aunque las licencias parentales son una herramienta importante de las políticas públicas, deben complementarse con otras estrategias que fomenten su uso pleno.



Un padre mira a su hijo con amor y orgullo. © Plan International Filipinas

Servicios de apoyo

A continuación se presentan algunas propuestas de medidas para mejorar los servicios, dirigidas a las principales instituciones (y a sus trabajadores) que prestan servicios de salud, protección social, atención infantil y educación inicial dirigidas a los niños pequeños y a sus cuidadores.

Medidas en los servicios de salud materna, neonatal e infantil

Invitar a los hombres a los servicios de maternidad, con el consentimiento de las mujeres

Los trabajadores de la salud pueden invitar a los hombres a asistir a las visitas prenatales, de asistencia durante el parto y de atención posterior al parto, pero solo si las mujeres lo desean. No obstante, debe recordarse tanto al personal como a los usuarios que la presencia de los hombres no es obligatoria para prestar la atención.

Incluir al padre como progenitor en los servicios de salud infantil

Los servicios de salud familiares y del niño deben registrar a los hombres, junto con las mujeres, como cuidadores principales y personas de contacto, e invitarlos a participar



en el seguimiento del crecimiento de sus hijos, en las vacunaciones y en las visitas de control del niño sano. También se deben adaptar las actividades de extensión, incluidas las visitas domiciliarias, para favorecer su participación.

Adaptar los establecimientos de salud para que sean más acogedores para los hombres

Además, se pueden introducir otros cambios para hacerlos participar sin menoscabar la privacidad y la dignidad de las mujeres, como disponer de suficientes sillas y espacios para ellos, habitaciones de parto privadas, cortinas de privacidad en las salas compartidas, baños separados y materiales informativos —como carteles y folletos— en los que aparezcan hombres como cuidadores (véase el recuadro «Aumentar la implicación de los hombres en los servicios de salud materna, neonatal e infantil»). Otra medida que facilita el acceso de los hombres y las familias es ampliar el horario de atención fuera de la jornada laboral y ofrecer servicios fuera de los establecimientos de salud.

Formar al personal de salud en los establecimientos y en las comunidades

El personal de salud debe conocer la relación entre la igualdad de género, la participación de los hombres y los resultados de salud de las mujeres y los niños. Por ese motivo, se debe prestar apoyo a estos trabajadores para que reflexionen sobre sus propias actitudes. Se pueden emplear ejercicios prácticos, como dramatizaciones o juegos de roles, que refuercen sus habilidades y su confianza al interactuar con hombres y parejas en los contactos habituales cuando se prestan servicios de salud materna, neonatal e infantil, así como servicios de nutrición. Por otro lado, es necesario capacitar al personal para que reconozca a las mujeres y niñas víctimas de violencia por parte de su cónyuge y pueda prestarles apoyo, además de saber cuándo no es apropiado fomentar la participación de los hombres (véase el estudio de caso de Ghana).

Implicación de los hombres en los servicios de salud materna, neonatal e infantil

Los servicios de salud materna, neonatal e infantil pueden adaptarse, y se ha de formar y ofrecer recursos a los trabajadores de la salud para atender a los hombres, alentándolos a proporcionar un cuidado cariñoso y sensible.

Desde el embarazo y durante el periodo posterior al parto, estos servicios pueden hacer participar a los hombres y brindarles la confianza, los conocimientos y las habilidades necesarias para respaldar una gestación saludable, facilitar el acceso oportuno de las mujeres y los niños

a los servicios esenciales de salud y promover una nutrición materna e infantil adecuada.

Asimismo, los servicios pueden ayudar a los hombres a comprender de qué modo su comportamiento influye directamente en el desarrollo y el bienestar de sus hijos. Pueden alentarlos a establecer vínculos afectivos con ellos, a mantener con ellos interacciones estimulantes y satisfactorias y a cuidarlos en el día a día. Cuando los servicios de salud materna, neonatal e infantil atienden a los hombres junto con sus

cónyuges, también pueden contribuir a que las relaciones conyugales sean más equitativas y solidarias.

La implicación de los hombres en estos servicios representa, además, una oportunidad para fomentar que busquen atención de salud. Por ejemplo, los servicios pueden detectar la depresión paterna, que afecta al bienestar de los hombres y a su capacidad de ofrecer un cuidado cariñoso y sensible, e influye en la salud mental y el bienestar de sus cónyuges (22).

Revisar los programas de formación y los programas de crianza para futuros padres

Es preciso adaptar los programas de crianza y las sesiones para futuros progenitores que se organicen con la participación de los trabajadores o en el marco del sistema de salud, a fin de incluir mejor a los hombres. En su diseño y adaptación deben participar tanto los hombres como las mujeres, con objeto de determinar las mejores maneras de influir en los hombres. Es importante invitarlos a participar y promover su implicación, ya sea mediante sesiones exclusivas para hombres o conjuntas para parejas. También se debe garantizar la atención a las familias en situación de vulnerabilidad —incluidas las familias refugiadas y desplazadas—, así como a hombres con características diversas en cuanto a edad, identidad de género, origen étnico, lugar de residencia y capacidades, y a los distintos modelos familiares.

Medidas en los servicios de aprendizaje temprano

Integrar a los hombres en un proceso más amplio de aumento de la implicación de los cuidadores

Los servicios de aprendizaje temprano pueden ser formales o informales y desarrollarse en distintos espacios, como los centros de cuidado infantil, los jardines de infancia y las escuelas preescolares. Sus responsables, cuidadores y educadores pueden promover la implicación de los hombres en el marco de un proceso más amplio de fortalecimiento de las relaciones familiares y de incremento de la implicación de los cuidadores en la atención y la educación de sus hijos. En estos espacios se debe invitar explícitamente a los hombres a participar en las reuniones y jornadas de actividades, y programarlas en horarios que faciliten la asistencia tanto de las mujeres como de los hombres, procurando que el tiempo de los varones no se priorice sobre el de las mujeres.

Revisar los programas y materiales de aprendizaje sobre la primera infancia

Los planes de estudio y los materiales lúdicos y de aprendizaje se deben adaptar para que cuestionen las expectativas relativas a los géneros y los comportamientos y funciones de hombres y mujeres, de manera que muestren representaciones positivas de los hombres como cuidadores cariñosos y sensibles.

Contratar a más hombres

Los centros de cuidado infantil, los jardines de infancia y las escuelas preescolares pueden contratar a varones no solo para cargos de gestión, sino también como cuidadores y educadores en contacto directo con los niños. De este modo, se ofrecen a los niños pequeños y a sus familias modelos masculinos positivos y la oportunidad de ver a hombres dedicados a cuidar junto a las mujeres.

Medidas en los servicios de protección de la infancia y de protección social

Adaptar los servicios existentes para implicar a los hombres

Es necesario colaborar con los trabajadores de primera línea y con las familias para determinar la manera en que los mecanismos de protección de la infancia y los servicios de protección social que atienden a familias con niños pequeños pueden adaptarse para implicar a los hombres cuidadores. El diseño y el contenido de estos servicios —como los programas de asistencia social o de transferencias monetarias y las redes de protección de la infancia— pueden modificarse para promover la corresponsabilidad de los hombres en las tareas domésticas y en las tareas de cuidado, fortalecer las relaciones de coparentalidad y prevenir la violencia. Debe ofrecerse capacitación a estos proveedores de servicios para que sepan cómo contactar, acoger y orientar a los hombres aplicando un enfoque basado en sus aptitudes.

¿Sabía usted?

Más del

80%

del cerebro humano se forma en los primeros tres años de vida.

El cuidado y el apoyo que el padre, la madre y otros cuidadores brindan a las niñas y niños en sus primeros años es fundamental para el desarrollo saludable del cerebro.

0-3

El cerebro humano se desarrolla más rápido desde la concepción hasta los 3 años de vida que en cualquier otro momento.

Cuidar, proteger y apoyar a los cuidadores y las niñas y niños es esencial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En los primeros años de vida, los padres, los familiares cercanos y otros cuidadores son los que están más cerca de la niña o niño pequeño y, por tanto, los mejores proveedores de cuidados cariñosos y sensibles. Con el fin de proporcionar a los cuidadores tiempo y recursos para proporcionar cuidados cariñosos y sensibles, deben establecerse políticas, servicios y mecanismos de apoyo a la comunidad

El cuidado cariñoso y sensible mejora la salud, la productividad y la cohesión social a lo largo de la vida, y sus beneficios persisten en la próxima generación.

En los países de ingresos bajos y medianos, 250 millones de niñas y niños menores de 5 años —más del **40% de los niños**— están más expuestos a no alcanzar su potencial de desarrollo debido a la pobreza y el abandono (23).

Cada **US\$1 adicional invertido** en el desarrollo de la primera infancia puede producir **una rentabilidad de entre US\$6 y US\$17** (24).

Formación del personal de salud

Desde 2016, la ONG Plan Internacional colabora con el Sistema Nacional de Salud de Ghana en la aplicación del programa Strengthening Health Outcomes for Women and Children (SHOW), con el objetivo de que las adolescentes, las mujeres y sus parejas masculinas tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, así como de salud materna, neonatal e infantil, que tengan en cuenta las cuestiones relativas al género y se adapten a las adolescentes. Además de trabajar directamente con los hombres, el programa SHOW también colabora con las oficinas regionales y distritales de salud para mejorar la capacidad de los establecimientos y del personal de salud, a fin de promover la implicación de los hombres en la salud sexual y reproductiva y en la salud materna, neonatal e infantil.

Se impartieron programas de capacitación dirigidos a voluntarios comunitarios y a trabajadores de la salud, tanto en los establecimientos como en el entorno comunitario, en los que se abordaron las barreras relativas al género que dificultan el acceso y la utilización de los servicios de salud por parte tanto de las mujeres como de los hombres. La formación mejoró las competencias del personal para acoger y atender a los hombres durante las consultas y las visitas domiciliarias, y les permitió poner en práctica estas habilidades. Además, se ofreció formación a los responsables de los servicios de salud sobre competencias para realizar una supervisión a fin de

prestar apoyo. Con objeto de facilitar la implicación de los hombres en los servicios de salud materna, neonatal e infantil, respetando siempre la privacidad de las mujeres, se introdujeron pequeñas mejoras de bajo costo en las infraestructuras de los establecimientos de salud.

Los resultados finales mostraron un aumento significativo en la proporción de servicios de salud que cumplían con los criterios de calidad y sensibilidad en materia de género. Asimismo, aumentó la demanda de los servicios prenatales, de parto y posteriores al parto por parte de las mujeres, así como su satisfacción con ellos. Por su parte, los hombres demostraron poseer un mejor conocimiento de la información principal sobre la igualdad de género y expresaron actitudes más favorables hacia sus cónyuges en lo relativo tanto a la búsqueda y el uso de servicios como a la toma de decisiones autónomas sobre su salud. Tanto los hombres

como las mujeres informaron de que había aumentado el apoyo prestado por los hombres al uso de los servicios de salud por parte de las mujeres, aunque este aumento fue menos pronunciado de lo previsto inicialmente. Según los datos, ello se debió a dos causas principales: en primer lugar, el programa generó mayores expectativas sobre lo que se considera un apoyo «muy bueno» por parte de los hombres, lo que llevó a percibir que algunos de ellos no alcanzaban ese nivel; y, en segundo lugar, la pandemia de COVID-19 y las medidas de control incrementaron la carga de tareas domésticas no remuneradas, que recaen de manera desproporcionada sobre las mujeres, con escaso apoyo de los hombres en general.

Para más información, véanse [la descripción general del programa SHOW](#) y [el enfoque sobre la implicación de los hombres](#).



Comunidades empoderadas

A continuación se presentan propuestas de medidas que pueden adoptarse en el entorno social para establecer un entorno propicio que favorezca la implicación de los hombres, incluidas las iniciativas destinadas a transformar las actitudes de género compartidas y a promover normas positivas que respalden el papel de los hombres como cuidadores.

Respaldo a las comunidades para que lideren el cambio

Es preciso ofrecer oportunidades para que la población reflexione y dialogue sobre las repercusiones de las actitudes, las normas y las expectativas de género en la implicación de los hombres en el cuidado y el desarrollo de los niños, y para que alcance colectivamente acuerdos sobre los cambios que considere necesario

introducir. Además, conviene aprovechar estas oportunidades, como los diálogos comunitarios, para poner de relieve las normas positivas en las que basarse, aumentar la sensibilización sobre las políticas relativas a la implicación de los hombres y corregir las ideas erróneas existentes.

Colaborar con los dirigentes comunitarios

Es necesario prestar apoyo a los dirigentes comunitarios, tanto religiosos y tradicionales como políticos, así como a otras personas influyentes (por ejemplo, personalidades de los medios de comunicación) que ya estén dando ejemplo de paternidad activa o puedan contribuir a fomentar la implicación de los hombres (véase el estudio de caso de Georgia). Con ese fin, se les deben ofrecer oportunidades para reflexionar sobre las consecuencias de las normas de género en sus propias vidas y prestarles apoyo en su labor comunitaria para liderar, respaldar y alentar el cambio. Además, es preciso colaborar con ellos para promover la sensibilización sobre los beneficios de la implicación de los hombres, facilitar los esfuerzos comunitarios destinados a corregir las normas de género

desiguales que obstaculizan dicha implicación, y mejorar las normas y prácticas existentes o nuevas que fomenten la corresponsabilidad de los hombres en las tareas de cuidado.

Invertir en educación y promoción de la salud

Se deben utilizar estrategias de comunicación para el cambio social y conductual con el fin de transformar progresivamente las actitudes, las expectativas y las prácticas relacionadas con el cuidado por parte de los hombres. Es preciso mostrar representaciones positivas de hombres que establecen vínculos afectivos con sus hijos, se implican como cuidadores cariñosos y sensibles y comparten responsabilidades con sus cónyuges. El contenido de estos mensajes debe basarse en pruebas y ser pertinente; por tanto, es importante que se elaboren y validen junto con el entorno social. Además, se pueden emplear medios y canales digitales adecuados, como carteles, vallas publicitarias, el teatro, la radio, los teléfonos móviles e internet, e integrar estos contenidos en los anuncios de servicio público (por ejemplo, sobre salud o educación) o en la publicidad del sector privado (véase el estudio de caso de Georgia).

GEORGIA

Una campaña nacional para transformar actitudes y comportamientos

En 2015, la oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Georgia y la organización no gubernamental Care Together lanzaron la campaña nacional MenCare con el objetivo de promover la implicación de los hombres como padres y cuidadores equitativos y no violentos, a fin de mejorar el bienestar de las

familias, la igualdad de género y la salud de las madres, los niños y los propios padres. La campaña se basó en un estudio de 2013 acerca de los hombres y las relaciones de género en ese país, que reveló que había pocos varones que cuidaran cotidianamente de sus hijos y que los estereotipos relativos a los géneros les impedían desempeñar un papel afectuoso como padres, esposos, cónyuges y familiares.

La iniciativa georgiana, que se inspira en la campaña mundial [MenCare](#), adopta un enfoque positivo y utiliza métodos innovadores para fomentar el diálogo y modificar las percepciones sobre el papel de los hombres como cuidadores. Por ejemplo, se utilizan proyectos fotográficos, blogs de padres, lecturas de libros infantiles por parte de padres conocidos, canciones populares, recopilaciones de relatos, un programa de telerrealidad con hombres famosos, la Copa de

Fútbol de los Padres (apoyada por la Federación Georgiana de Fútbol) y celebraciones del Día del Padre en las redes sociales. Esta campaña, galardonada y ampliamente reconocida, goza de gran notoriedad no solo entre los hombres, sino también entre sus familias, sus comunidades y los responsables de la formulación de políticas.

Basándose en el éxito de esta campaña, se han puesto en marcha varias intervenciones dirigidas a los padres, como grupos de padres, seminarios de un día de duración denominados «Hombres que hablan con hombres» y el programa formativo de ocho sesiones «Escuela de Padres». Con los años, la campaña ha evolucionado, pasando del concepto de paternidad activa al de asociaciones equitativas y, más recientemente, a la promoción de políticas familiares favorables, como las licencias parentales.

Para más información, véase el folleto de [MenCare Georgia](#).





Padre e hijo jugando. © Alfred Tschager

Capacidades de los cuidadores

A continuación se proponen intervenciones para mejorar las capacidades de los cuidadores, que suele ofrecer el personal de organizaciones no gubernamentales, otros hombres, trabajadores de salud comunitaria o miembros y dirigentes de la comunidad.

Aprovechar los servicios existentes para llegar a los hombres

Los enfoques destinados a mejorar las capacidades de los cuidadores pueden aplicarse directa o indirectamente a través de los servicios existentes, como se describe en el apartado anterior sobre los servicios de apoyo. Al igual que ocurre con los servicios, los trabajadores de primera línea necesitan respaldo para reflexionar sobre sus propias actitudes con respecto a los géneros y recibir formación sobre el modo de orientar a los hombres y responder ante la violencia familiar. Las intervenciones con hombres deben complementarse con iniciativas equivalentes dirigidas a mujeres, preferiblemente mediante algunas sesiones por separado y otras conjuntas.

Ofrecer oportunidades de apoyo entre hombres

Las intervenciones grupales ofrecen espacios seguros para el aprendizaje mutuo, la reflexión crítica y el diálogo, y fomentan la adquisición de habilidades y el apoyo entre pares. De este modo, brindan a los participantes la oportunidad de integrar lo aprendido en su experiencia vital. Estos grupos también pueden dar lugar a una masa crítica de hombres dispuestos a promover cambios en su entorno social. En cuanto a las sesiones para parejas, pueden favorecer la comunicación y reforzar las competencias relacionales, con el fin de ayudar a los progenitores a compartir el cuidado y la toma de decisiones, así como a mantener relaciones respetuosas y no violentas (8) (véase el estudio de caso de Rwanda).

Ofrecer apoyo individual en el hogar

Si se planifican en el momento adecuado, las visitas domiciliarias pueden ser uno de los medios más eficaces para influir en los hombres cuidadores, observar sus interacciones con los niños y proporcionarles orientación directa y asesoramiento práctico. Esta labor con los hombres puede integrarse en los programas de visitas domiciliarias ya existentes, como los que realizan los trabajadores de salud comunitaria o los de protección social. A tal fin, puede

ser necesario ajustar el horario de las visitas, contratar a varones para llevarlas a cabo o incluir nuevos temas, como las interacciones entre padres e hijos, la no violencia y las relaciones familiares equitativas.

Ofrecer apoyo individual mediante mentorías

La mentoría consiste en prestar apoyo personalizado a los hombres cuidadores, en un entorno seguro, generalmente a cargo de hombres mayores y respetados en la comunidad. Este acompañamiento permite adaptar las intervenciones de apoyo a las necesidades individuales y facilita la interacción con los hombres allí donde se encuentren.

Utilizar métodos digitales

Muchos hombres tienen acceso a tecnologías digitales, como la mensajería SMS, las aplicaciones, las redes sociales y las plataformas en internet, que pueden aprovecharse para transmitirles información y mensajes que promuevan su implicación, la interacción con sus hijos y el apoyo a sus cónyuges. Pueden programarse mensajes personalizados con información específica y oportuna en las distintas etapas del embarazo y los primeros años de vida de los niños, que se pueden integrar en las intervenciones de salud digital ya existentes.

Redefinir la paternidad

La intervención Bandedereho («un modelo que seguir»), que se desarrolla en Rwanda y se dirige a los padres de niños menores de cinco años, consiste en unas 15 sesiones semanales con actividades participativas y debates grupales que incluyen varias sesiones para parejas. Estas sesiones fomentan la reflexión crítica sobre las funciones de cada género, promueven la implicación de los hombres en la atención prenatal, el parto y el cuidado infantil, y proporcionan a los hombres y a sus cónyuges habilidades para la crianza y las relaciones conyugales. El programa, adaptado del [Programa P](#), trata temas como el género y el poder, la paternidad, la comunicación y la adopción de decisiones dentro de la pareja, la violencia intraconyugal, los cuidados, el desarrollo infantil y la implicación de los hombres en la salud reproductiva y materna. La intervención se puso a prueba entre 2013 y 2015 con más de 1700 parejas.

En un ensayo controlado aleatorizado sobre el programa Bandedereho se demostró que este dio lugar a mejoras tanto en la asistencia de mujeres y hombres a las visitas de atención prenatal como en el tiempo que los hombres dedicaban a cuidar a sus hijos, en las relaciones de pareja y en la reducción de la violencia, tanto de los hombres contra las mujeres como de hombres y mujeres contra los niños (8). Recientemente se realizó un estudio de seguimiento en el que se constató que muchos de estos efectos se habían mantenido seis años después y se observaron

mejoras en las prácticas de crianza y en la evolución emocional y conductual de los niños.

Actualmente, este programa se está ampliando en el sistema de salud ruandés con el apoyo del Centro Biomédico de Rwanda, el Centro de Recursos para Hombres de Rwanda y el Centro Equimundo para las Masculinidades y la Justicia Social (anteriormente Promundo-US).

Para más información sobre el programa Bandedereho, véase [el breve documental producido por la Corporación Británica de Radiodifusión \(BBC\)](#).



Un padre cuida de sus hijos y los guía mientras pasea con ellos por Rwanda. © Perttu Saralampi

Seguir avanzando

Con independencia de la situación actual, las instancias normativas y los responsables de los programas de todos los países pueden promover la implicación de los hombres cuidadores y prestarles apoyo para que ofrezcan un cuidado cariñoso y sensible. Los servicios que trabajan con mujeres, niños y familias pueden ayudar a los hombres a desarrollar plenamente su potencial para cuidar aplicando algunas de las medidas descritas en este documento.

Cada vez hay más intervenciones basadas en pruebas que se dirigen a los hombres cuidadores y a las parejas, si bien la mayoría solo se han aplicado a pequeña escala. Es preciso fomentar la colaboración multisectorial para determinar cómo adaptar el contenido de estas intervenciones y la formación necesaria, de modo que puedan integrarse en los servicios públicos —como los de salud,

infancia y protección social, incluidos los programas de transferencias monetarias— y para obtener más pruebas de sus efectos positivos.

Este proceso de adaptación puede facilitarse mediante métodos de investigación sobre la ejecución, que permitirán comprender los principales factores que influyen en el funcionamiento de los programas, a quién benefician y cómo pueden adaptarse a distintos contextos. Una vez integradas las intervenciones, deberán realizarse actividades de seguimiento y evaluación para garantizar su calidad, coherencia y eficacia al aplicarlas a gran escala.

Con el tiempo, estos cambios, junto con las iniciativas impulsadas por la población para transformar las normas de género, contribuirán a normalizar la participación de los hombres como cuidadores solidarios, comprometidos e igualitarios en la vida de sus hijos.

De ese modo, se conseguirá que más niños y jóvenes crezcan teniendo como modelos a hombres que cuidan y se sientan alentados a desarrollar su propia capacidad en ese ámbito.

Recordar

La implicación de los hombres en el cuidado cariñoso y sensible debe formar parte del objetivo más amplio de alcanzar la igualdad de género.

Fortalecer

Los servicios pueden adaptarse para atraer más a los hombres y favorecer que cuiden a sus hijos desde el principio.

Agregar

Es necesario establecer entornos propicios para que los hombres presten cuidados, modificando las normas y adoptando políticas de apoyo.

Recursos seleccionados

Being intentional about gender-transformative strategies

<https://www.unicef.org/gender-equality/action-plan>

Gender-responsive parenting technical note and tip sheet

https://www.unicef.org/eca/media/16436/file/Gender_Responsive_Parenting.pdf

https://www.unicef.org/eca/media/16446/file/Tips_on_Gender_Responsive_Parenting.pdf

How to engage men in nurturing care across the early life stages

<https://nurturing-care.org/engaging-men-in-nurturing-care-across-the-life-stages/>

MenCare: a global fatherhood campaign

<http://men-care.org/>

Promoting men's engagement in early childhood development: a programming and influencing package

<https://plan-international.org/publications/promoting-mens-engagement-in-early-childhood-development/>

Programa P: Un Manual para la Paternidad Activa

<https://www.mencare.org/resources/program-p/>

Referencias

1. OMS, UNICEF, Grupo del Banco Mundial. El cuidado cariñoso y sensible para el desarrollo en la primera infancia. Marco para ayudar a los niños y niñas a sobrevivir y prosperar a fin de transformar la salud y el potencial humano. Organización Panamericana de la Salud; 2021 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/272603>, consultado el 1 de julio de 2022).
2. Tokhi M, Comrie-Thomson L, Davis J, Portela A, Chersich M, Luchters S. Involving men to improve maternal and newborn health: a systematic review of the effectiveness of interventions. *PLoS ONE*. 2018;13(7):e0191620.
3. Diniz E, Brandão T, Monteiro L, Verissimo, M. Father involvement during early childhood: a systematic review of the literature. *Journal of Family Theory & Review*. 2021;13:77-99.
4. Levtoy R, van der Gaag N, Greene M, Kaufman M, Barker G. Panorama del estado de los padres en el mundo: resumen y recomendaciones. Una publicación de MenCare. Washington, D.C.: Promundo, Rutgers, Save the Children, Sonke Gender Justice, MenEngage Alliance; 2015 (https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/state-of-the-worlds-fathers_executive-summary_spanish_web.pdf, consultado el 4 de mayo de 2022).
5. van der Gaag N, Heilman B, Gupta T, Nembhard C, Barker G. State of the world's fathers: unlocking the power of men's care. Washington, D.C.: Promundo-US; 2019 (<https://www.mencare.org/resources/state-of-the-worlds-fathers-unlocking-the-power-of-mens-care/>, consultado el 26 de noviembre de 2025).
6. Yargawa J, Leonardi-Bee J. Male involvement and maternal health outcomes: systematic review and meta-analysis. *Journal of Epidemiology and Community Health*. 2015;69(6):604-612.
7. Fisher J, Cabral de Mello M, Patel V, Rahman A, Tran T, Holton S, et al. Prevalence and determinants of common perinatal mental disorders in women in low- and lower- middle-income countries: a systematic review. *Bull World Health Organ*. 2012;90:139G-49G.
8. Doyle K, Levtoy R, Barker G, Bastian GG, Bingenheimer JB, Kazimbaya S, et al. Gender-transformative Bandebereho couples' intervention to promote male engagement in reproductive and maternal health and violence prevention in Rwanda: findings from a randomized controlled trial. *PLoS ONE*. 2018;13(4):e0192756.
9. Feinberg ME, Kan ML. Establishing family foundations: intervention effects on coparenting, parent/infant well-being, and parent-child relations. *J Fam Psychol*. 2008;22:253-63.
10. Comrie-Thomson L, Webb K, Patel D, Wata P, Kapamurandu Z, Mushavi A, Nicholas MA, Agius PA, Davis J, Luchters S. Engaging women and men in the gender-synchronised, community-based Mbereko+Men intervention to improve maternal mental health and perinatal care-seeking in Manicaland, Zimbabwe: a cluster-randomised controlled pragmatic trial. *J Glob Health* 2022;12:04042.
11. Comrie-Thomson L, Gopal P, Eddy K, Baguiya A, Gerlach N, Sauvé C, et al. How do women, men, and health providers perceive interventions to influence men's engagement in maternal and newborn health? a qualitative evidence synthesis. *Soc Sci Med*. 2021;291:114475.
12. Martin SL, McCann JK, Gascoigne E, Allotey D, Fundira D, Dickin KL. Mixed-methods systematic review of behavioral interventions in low and middle-income countries to increase family support for maternal, infant, and young child nutrition during the first 1000 days. *Current Developments in Nutrition*. 2020;4(6):nzaa085.
13. Sarkadi A, Kristiansson R, Oberklaid F, Bremberg S. Fathers' involvement and children's developmental outcomes: a systematic review of longitudinal studies. *Acta Paediatrica*. 2008;97(2):153-58.
14. Cabrera NJ, Tamis-LeMonda CS, editors. Handbook of father involvement: multidisciplinary perspectives, second edition. New York: Routledge; 2013.
15. Burgess A. The costs and benefits of active fatherhood: evidence and insights to inform the development of policy and practice. London: Fathers Direct; 2006 (<https://fathers.co.za/wp-content/uploads/2015/02/The-costs-and-benefit-of-active-fatherhood.pdf>, consultado el 4 de mayo de 2022).
16. Digolo L, Asghar K, Berry V, Mitchell S, Rumble L, Alemann C, et al. Evidence review: parenting and caregiver support programmes to prevent and respond to violence in the home. The Prevention Collaborative; 2019 (<https://prevention-collaborative.org/wp-content/uploads/2019/11/Evidence-Review-Parenting-programmes-lowres-23112019.pdf>, consultado el 4 de mayo de 2022).
17. Ashburn K, Kerner B, Ojamuge D, Lundgren R. Evaluation of the responsible, engaged, and loving (REAL) fathers initiative on physical child punishment and intimate partner violence in Northern Uganda. *Prev Sci*. 2017 Oct;18(7):854- 864.
18. MOMENTUM. How to engage men in nurturing care across the life stages. Washington, DC: USAID MOMENTUM Country and Global Leadership; 2022 (<https://nurturing-care.org/engaging-men-in-nurturing-care-across-the-life-stages/>, consultado el 25 de noviembre de 2025).
19. Alemann C, Garg A, Vlahovicova K. The role of fathers in parenting for gender equality. Washington D.C.: Promundo-US; 2020 (https://www.un.org/development/desa/family/wp-content/uploads/sites/23/2020/06/Parenting-Education_-the-role-of-fathers_-paper_CA.pdf, consultado el 26 de noviembre de 2025).
20. Díaz LS, Saldías J, Contreras Y, Pizarro P. Apoyo social para la parentalidad: experiencias en programas de infancia en Chile. *Revista Perspectivas*. 2019;33:31-56.
21. Baird M, Hill E. Paternity leave in the Philippines. Sydney: The University of Sydney, Sydney Southeast Asia Centre; 2019 (https://investinginwomen.asia/wp-content/uploads/2019/05/FS_Paternity-Leave-Philippines.pdf, consultado el 1 de septiembre de 2022).
22. Paulson JF, Bazemore SD. Prenatal and postpartum depression in fathers and its association with maternal depression: a meta-analysis. *JAMA*. 2010;303:1961-1969.
23. Chunling L, Black MM, Richter LM. Risk of poor development in young children in low-income and middle-income countries: an estimation and analysis at the global, regional, and country level. *Lancet GlobHealth*. 2018;4(12):e916-22. doi:10.1016/S2214-109X(16)30266-2.
24. Heckman JJ. There's more to gain by taking a comprehensive approach to early childhood development. Chicago: The Heckman Equation; 2017 (https://heckmanequation.org/wp-content/uploads/2017/01/F_Heckman_CBAOnePager_120516.pdf, consultado el 26 de noviembre de 2025).
25. Jensen SK, Placencio-Castro M, Murray SM, Brennan RT, Goshev S, Farrar J, et al. Effect of a home-visiting parenting program to promote early childhood development and prevent violence: a cluster-randomized trial in Rwanda. *BMJ Global Health*. 2021;6:e003508.

Marco para el cuidado cariñoso y sensible durante la primera infancia

AGRADECIMIENTOS

El *Marco del cuidado cariñoso y sensible para el desarrollo en la primera infancia: un marco para ayudar a los niños a SOBREVIVIR y PROSPERAR a fin de TRANSFORMAR el potencial humano* (1) se basa en las evidencias más recientes sobre el modo en que se produce el desarrollo infantil y sobre las políticas e intervenciones eficaces que pueden mejorar el desarrollo en la primera infancia.

La OMS, el UNICEF y el Grupo del Banco Mundial elaboraron el Marco en colaboración con la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño, la Red de Acción para el Desarrollo del Niño en la Primera Infancia y muchos otros asociados a fin de proporcionar una hoja de ruta para alcanzar los Objetivos de

Desarrollo Sostenible y los objetivos de sobrevivir, prosperar y transformar de la Estrategia Mundial sobre la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente. Presentado durante la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo del 2018, describe: a) por qué los esfuerzos para mejorar la salud, el bienestar y el capital humano deben empezar en los primeros años de vida, entre el embarazo y los 3 años de edad; b) las principales amenazas para el desarrollo del niño en la primera infancia; c) cómo el cuidado cariñoso y sensible protege a los niños pequeños de los efectos de la adversidad y promueve el desarrollo físico, emocional y cognitivo; y d) lo que las familias y los cuidadores necesitan para proporcionar cuidados cariñosos y sensibles a los niños pequeños.

AUTORES:

Kate Doyle (Equimundo), Melanie Swan (Plan International), Sheila Manji (OMS), Bernadette Daelmans (OMS), Margaret Greene (Equimundo) y Saif Chaudhury (Plan International).

CONTRIBUIDORES:

Moses Abiero, Clara Alemann, Asmaa Alkhatib, Avni Amin, Mariam Bandzeladze, Beverly Bicaldo, Julianne Birungi, Betzabe Butron, Liz Comrie-Thomson, Catharina Cuellar, Given Daka, Prof. Hasina Ebrahim, Maya Elliot, Nina Gerlach, Ghassan Issa, Shreyasi Jha, Mary Kabati, Boniface Kakhobwe, Emmanuel Karamage, Giovanna Lauro, Zhao Li, Joan Mutinda, Bezaye Negassa, Lynette Okengo, Dr. George Owino, Annie Portela, Chemba Raghavan, Nicole Rodger, Daniel Rojas y Marco Rojas.

PARA MÁS INFORMACIÓN

nurturing-care.org
eccdan.org

ÚNETE A LA CONVERSACIÓN

#NurturingCare
@NurturingCare

CONTACTO

NurturingCare@who.int



Un padre pasa tiempo con su hijo y le enseña su entorno. © Alfred Tschager



Organización
Mundial de la Salud

unicef
para cada infancia



Cuidado cariñoso y sensible e implicación de los hombres: resumen temático [Nurturing care and men's engagement: thematic brief]

ISBN (OMS) 978-92-4-011964-2 (versión electrónica)

ISBN (OMS) 978-92-4-011965-9 (versión impresa)

© Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 2025.

Algunos derechos reservados. Esta obra está disponible en virtud de la licencia [CC BY-NC-SA 3.0 IGO](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/).